

Dermite du siège (diaper dermatitis)

Introduction : la dermite du siège représente une des atteintes cutanées les plus fréquentes de la petite enfance. Dans la majorité des cas, elle ne constitue qu'un désagrément bénin. Mais elle peut parfois être la manifestation de maladies systémiques plus conséquentes. On estime son incidence à 7-35% des enfants (même moins grâce aux langes jetables), avec un pic entre 9 et 12 mois.

Description des lésions cutanées :

Lésions élémentaires primitives :

- **Macule** : tache cutanée circonscrite, sans relief ni infiltration. Simple modification de la couleur de la peau. Le tatouage est une macule. L'haloéveus en est une aussi (pour autant qu'il n'y a pas de relief).
- **Papule** : petite lésion de <1cm de diamètre. Bien délimitée, en relief, ne contenant pas de liquide. On nomme plaque la somme de nombreuses papules accolées.
- **Nodule** : élévation cutanée ronde, saillante, palpable, de diamètre >1 cm. Résulte soit d'un œdème, soit d'un infiltrat inflammatoire ou tumoral dermique ou hypodermique (n'est pas forcément visible, mais palpable). En gros, une grande papule.
- **Pustule** : petite cavité remplie de pus (stérile/non stérile – déterminé par examen direct). Peut être folliculaire (si glande folliculaire au milieu) ou non folliculaire (pustule para-folliculaire).
- **Vésicule** : petite cavité intra-épidermique à contenu liquidien.
- **Bulle** : soulèvement circonscrit de l'épiderme, de volume supérieur à celui d'une vésicule. Contient un liquide clair, séropurulent ou hémorragique. Le site de jonction entre la bulle et la peau adjacente va déterminer l'épaisseur du toit ; plus le toit est fragile, plus la bulle est à risque d'éclater.
- **Urticaire** : éruption cutanée brutale de papules prurigineuses, œdémateuses, à limites nettes, de taille, de forme et de siège très variable. Persiste < de 24 heures. Si persiste >24h, on parle de vasculite urticarienne.

Lésions élémentaires secondaires :

- **Squame** : pellicule blanchâtre, épaissement de la couche cornée. Peut-être détacher par grattage tangentiel doux de la surface cutanée. Se voit par exemple dans le psoriasis.
- **Croûte** : formation dure, recouvrant une plaie ou une excoriation cutanée (i.e. perte des couches superficielles de la peau). Dessiccation d'un exsudat séreux, hémorragique ou purulent. Facilement détachable en bloc d'un coup de curette.
- **Rhagade = fissure** : perte de substance linéaire. S'observe aux paumes/plantes en cas d'hyperkératome (couche cornée trop épaisse).
- **Erosion** : perte de substance cutanée ou muqueuse superficielle. Ne laisse pas de cicatrices et ne dépasse pas la frontière dermo-hypodermique (contrairement à l'ulcère).
- **Ulcer** : perte de substance localisée suite à un traumatisme ou une nécrose. Entame au moins le derme moyen et profonde. Ne peut guérir sans laisser de cicatrice.
- **Atrophie** : amincissement du tégument, lisse et nacré (pearly). Perte de l'élasticité, du relief, des annexes (i.e. des poils). Aspect papier cigarette, structures au-dessous deviennent visibles.
- **Cicatrice hypertrophique** : cicatrice cutanée distinguée par son caractère hypertrophique, en relief, sans extension au-delà de la zone lésée. On parle de chéloïde. Elle a souvent une prédisposition familiale. Ne pas essayer de corriger par chirurgie, va aggraver la chose.
- **Lichénification** : réaction eczématiforme à des manœuvres incessantes de grattage ou de frottement. Présente en histologie une acanthose ou hyperkératose.

Dermite du siège – formes courantes :

Dermatite irritante de contact : plaques érythémateuses d'aspect brillant et épargnant les plis cutanés. Résulte de l'humidité, de la friction et un contact prolongé avec les enzymes trouvées dans les selles. Souvent chez des bébés qui ne sont pas changés assez souvent. Traitement : changer couches 6-8x/j, en tamponnant légèrement avec des lingettes humidifiées à l'eau (sans parfum ni savon). Appliquer crème contenant oxyde de zinc chaque fois. On peut éventuellement donner de l'hydrocortisone à court terme sous forme de crème si l'inflammation est importante, mais il faut être vigilant (le fait de recouvrir la peau avec le pampers augmente l'effet 10-100x).

Candidose des langes : plaques érythémateuses n'épargnant pas les plis cutanés, avec papules et pustules satellites. Y penser s'il y a ou a eu un traitement AB. Souvent associée à une candidose orale. Peut être primaire ou une complication de dermatite irritante. Diagnostic confirmé par examen direct de la peau ou culture positive en milieu de Sabouraud. Se traite par antifongiques (nystatin, cotrimazole...) ; topique si purement cutané, systémique si associée à une candidose orale.

S'inquiéter si mauvaise réponse au traitement (reconsidérer le diagnostic), ou si candidoses à répétition (chercher une immunodéficience).

Dermatite séborrhéique : affecte le scalp (croutes de lait), face, et ailleurs. Commence entre 3 et 4 semaines de vie, disparaît généralement au bout d'un an. Cause inconnue, probablement une augmentation de fonction/nombre de glandes sébacées. Représente peut-être une inflammation en réponse à la levure **pityrosporum ovale** (présente chez tout le monde). Traitement : huile d'amande et shampoing anti-séborrhéique pour les croutes de lait, antifongiques/faibles corticostéroïdes topiques pour ailleurs sur la peau.

Impetigo bulleux : bulles flaccides avec liquide transparent ou purulent, se rompent vite laissant des érosions croûtées. N'est généralement pas récurrent ou chronique, ne touche pas les muqueuses. Résulte d'une infection par *S. aureus* (toxine épidermolytique), à confirmer par culture. Se traite par AB topiques, voire systémiques si lésions plus étendues.

Folliculite : pustules érythémateux, centrés sur des follicules pileux. La plupart des lésions sont indolores et guérissent en 1 semaine environ, avec hyperpigmentation post-inflammatoire. Résulte d'une infection du follicule par *S. aureus*, éventuellement par streptocoque ou levure (confirmer par culture). Se traite par savons AB, AB topiques et systémiques.

Intertrigo : érythème brillant/lacéré, résulte de la friction peau contre peau et de la sueur. Se trouve au niveau des plis. Peut se surinfecter par *Candida* ou *Streptococcus pyogenes*. Se traite par pâte de zinc pour absorber l'humidité et des protéger des frottements. Antifongiques/AB si surinfection.

Dermatite de Jaquet : ulcères peu profonds/nodules ulcérés, bien délimités. Forme sévère de dermatite irritante. Multifactoriel : humidité, friction, enzymes des selles. Se traite par corticostéroïdes topiques faibles et AB, ainsi que protections contre frottements.

Dermite du siège – quelques formes moins courantes :

Dermatite péri-anale à streptocoques : érythème péri-anal bien délimité, parfois avec fissure ou décharge purulente. On constatera parfois une douleur/constipation (cercle vicieux des fissures anales). Résulte d'une infection à streptocoques β -hémolytiques du groupe A. Parfois accompagné d'une angine à streptocoques. À confirmer par culture. Se traite par pénicilline per os/érythromycine (macrolide), AB topiques et protections contre frottements.

Psoriasis : large plaques rouges, bien délimitées avec squames (se voient par grattage = signe de la bougie). Parfois difficile à distinguer d'une dermatite séborrhéique. On verra également des ongles en dés à coudre avec taches d'huile. Origine inconnue, mais la dermatite reflète sans doute le phénomène de Koebner. 5-25% des cas développeront un psoriasis dans les 10 ans qui suivent. Se traite en évitant les facteurs déclencheurs, émollients topiques, corticostéroïdes faibles, onctions de calcipotriol, photothérapie...

Acrodermatite enteropathica : se produit souvent lorsque l'enfant passe du lait maternel au lait de vache. Dermatite érosive péri-orificielle avec érythème et pustules. Peut ressembler à la dermatite de Jaquet mais ne répond pas aux traitements classiques. Autres indices : enfants avec peu de cheveux, diarrhées et cassure de leur courbe de croissance. Trouble autosomique récessif dans l'absorption du zinc (chute du zinc sérique). Se traite par administration orale de zinc et corticostéroïdes topiques faibles.

Histiocytose à cellules de Langerhans : vésicules ou pustules, souvent avec croûte hémorragique. Affecte le scalp, les paumes/plantes, plis cutanés et langes. Accompagnée d'une hépato-splénomégalie et lymphadénopathies. Une biopsie révélera S100+ et cellules CD1a+. Résulte d'une accumulation de cellules de Langerhans dans la peau/autres organes. Référer au dermatologue/oncologue pédiatrique. Se traite selon les organes atteints (prednisone, chimiothérapie, radiation, greffe de moelle...).

Granulome glutéal infantile : nodules rouges-violacés suite à une infection, résultant d'une corticothérapie. Histologie montre un infiltrat inflammatoire non spécifique. Se résout spontanément quelques mois après traitement de l'infection et arrêt des corticostéroïdes.

Ecthyma gangrenosum : papules hémorragiques qui progressent en plaques nécrotiques/bulles/ulcères. Souvent associées à une fièvre et des myalgies. L'ecthyma gangrenosum est une vasculite septique généralement associée au *Pseudomonas aeruginosa*. Diagnostic confirmé par Gram et culture. La plupart des enfants sont immuno-compromis ou ont une histoire de chimiothérapie. Se traite par aminoglycosides (AB systémiques).

Conclusions :

- Toujours chercher indices dans l'anamnèse et le status pour trouver le bon diagnostic.
- Identification de l'étiologie essentielle avant de prescrire un traitement
- Premiers buts du traitement : garder la peau sèche, protégée et dépourvue de toute infection
- Référer l'enfant au spécialiste si ne répond pas au traitement pour évaluer les DD et besoin éventuel de faire une biopsie.

Taches blanches de la peau

Introduction : les taches hypo/dépigmentées de la peau sont fréquentes. Mais il est important de savoir distinguer lesquelles sont bénignes et les quelles soulèvent un problème plus sérieux. On les classe en formes congénitales et acquises. Piège : souvent des tâches apparaissent chez les enfants caucasiens après leur première exposition au soleil, mais existent au fait depuis leur naissance (c'est juste que leur teint était trop clair pour qu'on les voie).

Formes congénitales :

Sclérose tubéreuse : maladie autosomale dominante avec 75% de mutations sporadiques et expression variable. Touche les deux genres. Se manifeste par le développement d'hamartomes cutanés, oculaires, cérébraux, cardiaques, pulmonaires, rénaux et osseux.

Clinique :

- Quelques signes majeurs :
 - macules hypo-pigmentées et lésions en forme de confettis (à la naissance ou peu après)
 - angiofibromes de la face (ressemblent à de l'acné mais contiennent du tissu conjonctif).
 - Fibromes péri-unguéales
 - Plaques fibreuses au niveau du front
- Autres manifestations : on verra souvent des épilepsies et un retard mental. Plus les épilepsies sont fréquentes, plus le retard mental sera sévère.
- Atteinte des divers organes (mentionnés ci-dessous pour les hamartomes).

Évaluation diagnostique : se fait via

- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| - CT/IRM cérébraux | - EEG | - Screening de la famille immédiate |
| - Échocardiographie | - RX thoracique | - Évaluation des os |
| - US rénaux | - Fundoscopie | |

Gestion d'une sclérose tubéreuse :

- Suivi multidisciplinaire régulier
- Prévention des épilepsies
- Monitoring et intervention précoce pour le retard mental
- Intervention chirurgicale en cas d'augmentation de la pression intra-crânienne.
- Angiofibrome facial : traitement topique avec sirolimus (Rapamycine), thérapie laser sous anesthésie générale.

Nevus depigmentosus or achromicus : peut être congénital ou apparaître pendant la petite enfance, et persister sans modification toute la vie. Généralement des lésions isolées, histoire familiale positive. Suite à un frottement, la zone initialement blanche devient rouge.

Nevus anemicus : anomalie développementale des VS cutanés → patch de peau avec vasoconstriction.

Distinction du nevus achromius : la zone blanche ne change pas de couleur avec le frottement.

Piebaldisme : mutation AD du proto-oncogène c-kit (code pour un récepteur de surface pour les SCGF/mast cell GF). Les manifestations cliniques résultent d'un défaut de migration des mélanoblastes à partir de la crête neurale, ainsi que de leur différenciation en mélanocytes. Parfois difficile à différencier du vitiligo (mais traitements pas les mêmes !!).

Manifestations cliniques :

- Dépigmentation persistante et réfractaire aux traitements
- Mèche de cheveux blancs dans 80-90% des cas (peut inclure les cils/sourcils)
- Parfois tache dépigmentée de forme triangulaire sur le front
- Contrairement à l'albinisme, la pigmentation oculaire est normale

Traitement :

- Masquage cosmétique
- Protection minutieuse contre le soleil
- Ré-épithélialisation par greffes autologues d'épiderme mis en culture après résection au laser

Mosaïcisme pigmentaire : groupe hétérogène de désordres avec hypo ou hyperpigmentation le long des **lignes de Blaschko** (lignes du développement ectodermique embryonnaire). Ces atteintes mosaïques ne sont généralement pas héréditaires. 30% ont d'autres anomalies associées (os, yeux, SNC), surtout lorsqu'il y a des changements pigmentaires étendus.

Syndrome de Waardenburg : groupe de maladies AD caractérisées par une mèche de cheveux blancs, 2 iris n'ayant pas la même couleur, dépigmentation cutanée et surdité de perception congénitale.

Formes acquises :

Vitiligo : à soupçonner si histoire familiale de maladies auto-immunes. Résulte d'une destruction auto-immune des mélanocytes. Touche 1% de la population, avec risques plus élevés dans la famille du patient atteint. Apparaît en général vers l'âge de 6 ans. Peut être déclenché par des traumatismes (phénomène de Koebner) et le stress (physique/émotionnel). Le diagnostic se pose notamment à l'aide de lampe UV (lampe de Wood).

Clinique : macules dépigmentées et bien définies, aux bords souvent hyperpigmentés. Affecte en premier lieu les plis et orifices cutanés, ainsi que les proéminences osseuses. On verra parfois aussi des mèches de cheveux blancs (**leukotrichia**) et souvent de halonevi (peuvent signaler un début de vitiligo).

Traitement :

- Stéroïdes topiques puissants
- Inhibiteurs de la calcineurine
- UVA/UVB
- Camouflage cosmétique (mais ponctuel et chronophage)
- L'évolution du vitiligo est imprévisible. La repigmentation apparaît comme des petites points (reflètent la migration des mélanocytes à partir des follicules pileux).

Hypopigmentation post-inflammatoire : est souvent associée à une grande variété de dermatoses inflammatoires/infections. L'hypopigmentation résulte d'une lésion des mélanocytes par l'inflammation qui du coup n'arrive plus à distribuer leur mélanine (via mélanosomes). Les lésions cutanées se voient plus facilement après une exposition aux UV. Il n'y a pas de traitement efficace, mais s'améliore généralement avec le temps.

Pityriasis alba : dermatite non spécifique avec hypopigmentation post-inflammatoire résiduelle. Cause inconnue. Touche enfants de 3-16 ans, souvent de couleur foncée. Les lésions hypopigmentées se voient souvent après une exposition au soleil sur le joues, tronc et membres proximaux.

Traitement : repigmentation peut prendre mois-années

- Corticostéroïdes topiques faibles ou inhibiteurs de la calcineurine
- Protection contre le soleil
- Emollients

Pityriasis versicolor : causé par **Malassezia furfur** (levure qu'on a tous sur la peau). Lésions plus apparentes après une exposition au soleil. Hypopigmentation résulte de l'acide azelaïc (inhibe la réaction dopa-tyrosine kinase).

Traitement : antifongique topique si pas trop sévère. Oral si sévère/récurrent/réfractaire.

Autres : lymphome cell-T cutané, lèpre